

内服薬に関するきまり 指示受け



医師は指示が切れる前に指示を出す。

看護師は、指示が切れる当日に確認し、指示が出ていない場合は、掲示板で医師に指示出しを依頼する。

医師が指示を出すと病棟マップの患者名に電球マークが出るので看護師は指示を確認する。但し定期処方電球マークが出ないので注意して確認する。

指示受けは処方日数分をインチャージシートで行う。

指示確認はその処方の服用開始日のみを患者スケジュールで行う。

看護師は薬局から届いた薬剤と処方箋の内容が一致しているか確認する。

内服開始の場合は経過表の観察項目欄に与薬実施記入欄を立ち上げる。*1

***1** については、自己管理薬については設定しない。看護師が与薬時間に、与薬または服薬確認を行うものについてだけ立ち上げ、入力する。

医師は、内服薬の中止・一部中止の指示を出した場合、中止処方箋を発行する。看護師は、中止処方箋に入力してある全ての薬剤と中止処方箋を薬局へおろす。中止処方箋を医師が発行し忘れていた場合は医師に、または医師事務に代行入力を依頼する。

鎮痛剤や下剤など、頓用へ変更する場合は、医師はその薬剤を中止し、新たに頓用として薬剤の指示を出す。看護師は中止指示の手順に基づいて処理を行い、新たな指示を受ける。薬剤の確認は電子カルテで行うため、この手続きを踏まずに変更すると、カルテ内の処方内容と実際に齟齬が生じるので必ず手順を踏む。

週1回または4週に1回等、間をおいて服用させる薬については、処方忘れを防止するために、以下の対策をとる。

①単独処方とする。

②医師が医師事務に代行入力を依頼した場合はカルテの掲示板の右上の枠に「薬剤名、次回処方日」等を医師事務が記載し、医師事務が服用の前日までに処方の代行入力を行う。看護師はそれが適切に行われているか予約日が近づいたらチェックする。

自己管理の吸入・外用薬（切れ日がきまっているもの）の処方箋は、破棄せず切れ日を記入して保管する。

臨時処方の切れ日調整はしない。但し、予約入院の患者のみ入院時に限り調整してよい。（処方は朝から事前に出ているが、実際の入院は昼から等の事情があるため。**この場合は、日切れ調整の為、朝分は破棄する。**）

【点眼薬について】

新しく処方された点眼薬の切れ日の目安について：1滴＝0.05mlなので1本5mlの点眼薬は1本100滴と考える。1日3回両目に点眼する場合、1回1滴と考え1日6滴 100滴÷6滴＝16.6日でおおよそ16日分と考え、16日後を切れの目安とするが、切れ日が近くなったら実際目で見えて確認する。